

EPREUVE DES MALADIES DE L'ENFANT

Session Janvier 2026 FMPM

- 1. Concernant les voies aériennes chez le fœtus :**
 - A. Elles sont remplies d'air
 - B. Elles sont remplies de liquide pulmonaire
 - C. Le liquide pulmonaire est produit par le placenta
 - D. Ce liquide participe à la croissance pulmonaire
 - E. Il disparaît progressivement à la naissance
- 2. Parmi les situations suivantes, lesquelles sont des facteurs fœtaux antépartum augmentant le risque de réanimation néonatale ?**
 - A. Retard de croissance intra-utérin (RCIU)
 - B. Grossesse < 37 SA
 - C. Grossesse multiple
 - D. Diabète gestationnel
 - E. Anomalie congénitale sévère
- 3. À propos du liquide amniotique, quelles situations sont évocatrices d'un risque d'asphyxie périnatale ?**
 - A. Liquide clair
 - B. Liquide méconial
 - C. Liquide teinté
 - D. Liquide sanglant
 - E. Liquide abondant clair
- 4. Les situations obstétricales suivantes sont des causes possibles d'asphyxie périnatale :**
 - A. Décollement placentaire
 - B. Hématome rétroplacentaire
 - C. Procidence du cordon
 - D. Latérocidence du cordon
 - E. Grossesse multiple sans complication
- 5. Un nouveau-né à J1 de vie, à terme, se présente dans un tableau d'insuffisance cardiaque, avec une différence de saturation entre le membre supérieur droit et le membre inférieur droit, la palpation des pouls retrouve des pouls brachiaux présents et des pouls fémoraux abolis, quel est votre diagnostic ?**
 - A. Une transposition des gros vaisseaux
 - B. Une tétralogie de Fallot
 - C. Une coarctation de l'aorte
 - D. Une communication interventriculaire
 - E. Un canal atrioventriculaire
- 6. Un nouveau-né à J1 de vie, à terme, se présente dans un tableau d'insuffisance cardiaque, les pouls brachiaux et fémoraux tous abolis, quel est votre diagnostic ?**
 - A. Une transposition des gros vaisseaux
 - B. Une tétralogie de Fallot
 - C. Une hypoplasie du ventricule gauche
 - D. Une communication interventriculaire
 - E. Un canal atrioventriculaire

7. Chez ce même nouveau-né, Le test d'hyperoxie retrouve une cyanose réfractaire. Comment se pratique ce test d'hyperoxie ?

- A. Mettre de l'oxygène à 100% pendant 10 minutes
- B. Mettre de l'oxygène à 50% pendant 10 minutes
- C. Mettre de l'oxygène à 50 % pendant 5 minutes
- D. Mettre de l'oxygène à 21 % pendant 5 minutes
- E. Mettre de l'oxygène à 21% pendant 10 minutes

8. La triade clinique caractéristique pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque du nourrisson :

- A. Une tachycardie
- B. Une dyspnée
- C. Une hépatomégalie
- D. Une cardiomégalie
- E. Des œdèmes

9. Parmi les complications métaboliques du prématuré, une seule proposition est fausse :

- A. Hyponatrémie
- B. Hypocalcémie
- C. Hypomagnésémie
- D. Hyperkaliémie
- E. Hypoglycémie

10. Devant un purpura fébrile la première conduite est : (Une seule proposition juste)

- A. L'administration d'antibiotique
- B. Le transfert
- C. La réalisation de la ponction lombaire
- D. La réalisation d'hémoculture
- E. La réalisation d'hémodiagrame

11- La prophylaxie de l'entourage en cas de méningite à méningocoque se base sur : (Une seule proposition juste)

- A. La ceftriaxone
- B. L'amoxicilline
- C. La rifampicine
- D. La gentamicine
- E. L'azithromycine

12- La méningite tuberculeuse est caractérisée par : (Une seule proposition juste)

- A. Une installation rapide
- B. Une installation insidieuse
- C. Une normoglycorrachie
- D. Une formule à prédominance PNN
- E. L'existence d'oreillon.

13- Dans la méningite bactérienne du nourrisson : (Une seule proposition juste)

- A. La raideur de la nuque est indispensable au diagnostic
- B. La fièvre isolée peut être le seul symptôme révélateur
- C. Le scanner cérébral est systématique
- D. Le traitement est démarré après isolement du germe
- E. La CRP est normale.

14- Chez le nourrisson le maintien de la tête : (Une seule proposition juste)

- A. Est acquis à 6 mois
- B. Est acquis à 3 mois
- C. Est acquis à 1 mois
- D. Est mis en évidence par le signe de parachute
- E. Est indépendant du tonus axial

15- Chez un nourrisson de 7 mois, le sang dans les selles doit faire éliminer :

- A. Une invagination intestinale aiguë
- B. Un rotavirus
- C. Un cholera
- D. Une infection urinaire
- E. Un shigella.

16- devant un nourrisson de 2 mois fébrile à 39 depuis 2 jours sans foyer trouvé à l'examen clinique, votre conduite est de : (Une seule proposition juste)

- A. Mettre sous antibiotique à domicile
- B. Faire une NFS CRP avant de décider
- C. Revoir le patient dans 24 heures
- D. Mettre sous antipyrétique à domicile
- E. Se contenter de l'examen clinique pour rassurer les parents.

17- Dans la tuberculose de l'enfant :

- A. Le BCG prévient la maladie à 100 %
- B. Le GENEXPERT peut être fait dans la biopsie ganglionnaire
- C. Le dépistage est la clef de la prévention
- D. La radio thorax n'est pas systématique
- E. L'intradermoréaction positive confirme la maladie.

18- Concernant l'asthme du nourrisson, quelles sont les propositions justes ?

- A- Il s'agit de la première maladie chronique de l'enfant
- B- La physiopathologie fait impliquer une amplification de la réponse TH1
- C- La radiographie thoracique face permet d'écarter les diagnostics différentiels
- D- Le traitement de fond est basé sur une association fixe de corticothérapie inhalée et bronchodilatateur de longue durée d'action
- E- L'objectif du traitement est le contrôle de la maladie

19- A propos de l'asthme chez l'enfant, quelle est la proposition fausse?

- A- Le diagnostic positif est basé sur la clinique et les explorations fonctionnelles respiratoires
- B- Le diagnostic de l'asthme est retenu si le VEMS/ CVF est inférieur à 90% et le VEMS augmente de 12% ou de 400ml après test au bronchodilatateur
- C- Le prick test peut être indiqué chez tout enfant âgé de plus de 3 ans
- D- Une exacerbation est classée en légère modérée et sévère
- E- Une éducation thérapeutique est un plan d'action individualisé sont indispensables pour une bonne prise en charge

20- S'agissant de la pneumonie chez l'enfant, cochez les réponses fausses

- A- Deuxième cause de décès chez l'enfant de moins de 5 ans
- B- Le diagnostic repose sur l'association de polypnée fébrile et sibilants avec aspect radiologique évocateur
- C- L'antibiothérapie vise le pneumocoque, elle est basée sur l'association amoxicilline et acide clavulanique
- D- S'il n'y a pas d'amélioration, il faut chercher des germes atypiques ou une complication
- E- Devant une pneumonie à répétition, il faut penser à un déficit immunitaire humoral

21. Un nourrisson de 4 mois, sans antécédents particuliers, consulte pour difficulté respiratoire évoluant depuis 48 heures. Les parents rapportent une rhinorrhée, une toux puis l'apparition d'une dyspnée sifflante. Température : 37,8 °C, Fréquence respiratoire : 58/min ; Saturation en O₂ à l'air ambiant à 91%. Il présente à l'inspection un tirage sous-costal et battement des ailes du nez et à l'auscultation des sibilants expiratoires diffus bilatéraux.

Cocher les réponses justes :

- A- Le patient a une bronchiolite virale surinfectée
- B- Le patient doit être hospitalisé
- C- La radiographie thoracique est indiquée

- D- Le patient présente une exacerbation aiguë d'asthme
- E- Il s'agit d'une obstruction des voies aériennes supérieures

22. Quel est l'examen paraclinique qui confirme le diagnostic de leucémie aiguë chez un enfant présentant des douleurs articulaires, une splénomégalie, et une hyperleucocytose ?

- A – Frottis sanguin
- B - Taux de réticulocytes
- C - Myélogramme
- D – Biopsie ostéo-médullaire
- E. Scintigraphie osseuse

23. Le déficit en G6PD est :

- A. Une anémie hémolytique auto-immune
- B. De transmission liée au sexe
- C. Anémie normochrome normocytaire arégénérative
- D. Nécessite une transfusion sanguine au cours de la crise de déglobulisation
- E. Déclenchée par l'ingestion de fèves

24- La maladie cœliaque chez le nourrisson :

- A. Se manifeste par des diarrhées chroniques avec dénutrition
- B. Cause une cassure de la courbe de poids
- C. Est confirmée par des anticorps antitransglutaminases positifs avec une atrophie villositaire
- D. Est traitée par un régime sans gluten
- E. Est traitée par une corticothérapie

25- Dans le reflux gastro-œsophagien du nourrisson :

- A. Les vomissements sont postprandiaux précoces et déclenchés par le changement de position
- B. La fibroscopie digestive est systématique
- C. La Ph métrie est indiquée si reflux atypique
- D. Une échographie abdominale permet de confirmer le diagnostic
- E. Le traitement est basé sur les IPP dans les cas compliqués d'œsophagite

26- Concernant le lait maternel :

- A. Les protéines sont majoritairement des caséines
- B. Le lactose est le principal glucide du lait maternel
- C. La teneur en lipides est constante au cours de la tétée
- D. Le lait maternel contient des acides gras essentiels
- E. Le colostrum est riche en immunoglobulines

27- Concernant la carence en fer :

- A. Elle est rare avant l'âge de 2 ans
- B. Se manifeste toujours par une anémie sévère
- C. Elle peut entraîner des troubles de développement psychomoteur
- D. Elle est secondaire à une hémolyse
- E. Elle peut être traitée par l'apport du fer par voie orale

28- Concernant le diabète de type 1, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Il s'agit d'un état d'hyperglycémie aiguë.
- B. C'est la forme de diabète la plus fréquente chez l'enfant.
- C. Il peut s'associer à la maladie cœliaque.
- D. L'insuline est le seul traitement.
- E. Il peut survenir chez un enfant de moins de 6 mois

29. Devant un retard de croissance caractérisé par un âge statural inférieur à l'âge pondéral, quelles sont les étiologies à évoquer ?

- A. Une maladie cœliaque
- B. Une hypothyroïdie
- C. Une maladie de Crohn

D. Un hypercorticisme

E. Une cardiopathie

30. Une fille de 8 ans est admise pour urines bouillon sale et bouffissure du visage. Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont correcte(s) pour orienter votre diagnostic :

A. Néphropathie familiale

B. Surdit   personnelle ou familiale

C. Une infection

D. Un   pisode ant  rieur similaire

E. Une photosensibilit   du visage avec   ruption

31. Une fille de 10 ans consulte pour une   nur  sie. En faveur de l'  nur  sie primaire monosymptomatique :

A. Propret   nocturne acquise    3 ans puis   nur  sie

B. Fuites diurnes

C. Imp  riosit   mictionnelle

D. Sommeil tr  s profond

E. Pr  sence d'un r  sidu post mictionnel tr  s important    l'  chographie

32. La n  phrose lip  idique se caract  rise par :

A. Sa corticor  sistance

B. Un seul   pisode

C. Le fait qu'elle constitue la premi  re   tiologie du syndrome n  phrotique chez l'enfant

D. Sa survenue avant l'  ge de 1 an

E. La n  cessit   d'une confirmation par la ponction biopsie r  nale

33. Les complications du purpura rhumato  de :

A. La n  crose cutan  e   tendue

B. L'invagination intestinale aig  e

C. L'orchite

D. Le syndrome n  phrotique

E. L'HTA en absence d'insuffisance r  nale

34. En faveur de l'arthrite juv  nile idiopathique :

A. Un risque ophtalmique en pr  sence d'AAN positifs

B. Un caract  re fugace et migrateur des arthralgies et arthrites

C. Une s  v  rit   d'  volution en pr  sence d'un facteur rhumato  de positif

D. Un risque de survenue d'un syndrome d'activation macrophagique plus important dans la forme syst  mique

E. Une aphtose bipolaire et une photosensibilit  

35. Vous   tes appel      la salle d'accouchement pour examiner un nouveau-n   qui pr  sente une tum  faction de la r  gion ombilicale couverte par une membrane translucide contenant des anses gr  les et centr  e par l'ombilic.

A- Il s'agit d'un gastroschisis.

B- Il s'agit d'une omphalocele.

C- Il faut v  rifier la perm  abilit   de l'  sophage.

D- Il faut examiner le p  rin  e.

E- Il faut lutter contre l'hypoglyc  mie.

36. Un nourrisson de 6 mois pr  sente des crises de pleurs paroxystiques avec refus de biberon.

A- Vous cherchez les vomissements bilieux.

B- Vous cherchez la rectorragie.

C- Vous demandez une   chographie abdominale.

D- Vous pensez    une invagination intestinale aig  e.

E- Vous demandez un abdomen sans pr  paration

37. Un nouveau-n   de 3 semaines normale jusqu'   y a 24 heures, pr  sente des vomissements bilieux, l'abdomen est plat. Vous pensez    :

- A- Une Atrésie duodénale.
- B- Un Volvulus sur mésentère commun.
- C- Une maladie d'Hirschsprung.
- D- Une atrésie du grêle.
- E- Une atrésie de l'œsophage.

38. Un nourrisson d'1 mois et demi présente depuis 3 jours des vomissements lactés. L'examen clinique trouve un nourrisson déshydraté.

- A- Il s'agit un volvulus sur mésentère commun.
- B- Il s'agit d'une sténose hypertrophique du pylore.
- C- Vous demandez une échographie abdominale.
- D- Vous demandez un ionogramme sanguin.
- E- Vous traitez par un antiémétique en ambulatoire.

39. Un garçon de 4 ans se présente pour distension abdominale constatée par les parents, sans autres anomalies, depuis 15 jours. L'examen note une masse ferme du flanc gauche sans autres anomalies. Les deux premiers diagnostics à évoquer sont :

- A- Hydronéphrose par syndrome de jonction gauche
- B- Un neuroblastome surrénalien gauche
- C- Un lymphome de Burkitt
- D- Un néphroblastome gauche
- E- Une dysplasie rénale multikystique gauche

40. Le premier bilan à faire :

- A- Biopsie tumorale
- B- Une imagerie par résonnance magnétique
- C- Une NFS
- D- Une échographie abdominale
- E- Un ECBU

41. Un garçon de 08 ans se réveille en se plaignant de douleur isolée, intense scrotale gauche. Le premier diagnostic est :

- A- Une tumeur testiculaire
- B- Une torsion testiculaire
- C- Une hernie inguinale
- D- Une varicocèle
- E- Une torsion d'annexes

42. Un nourrisson de 16 mois de sexe masculin est amené aux urgences pour vomissement bilieux et arrêt des matières et des gaz remontant à 20 heures avant l'admission. Hypotonique, température à 38°C, abdomen distendu et une tuméfaction inguinale droite inflammatoire douloureuse et irréductible. Le diagnostic retenu est :

- A- Une torsion du cordon spermatique.
- B- Une hernie inguinale droite étranglée.
- C- Une adénite inguinale droite.
- D- Un abcès des parties molles inguinales.
- E- Un kyste du cordon droit.

43. Votre conduite à tenir serait :

- A- Faire une réduction par taxis.
- B- Donner des antibiotique en ambulatoire.
- C- Drainer l'abcès des parties molles.
- D- Acheminer le malade au bloc pour réduction chirurgicale.
- E- Programmer une chirurgie du canal péritoneovaginale vers l'âge de 2 ans.

44. L'examen d'un garçon âgé de 3 ans suite à une boiterie indolore constatée depuis l'âge de la marche révèle un signe de Galleazzi positive au niveau de la cuisse, quelles sont les deux hypothèses à évoquer en premier parmi ces diagnostics.

- A- Une inégalité des deux membres inférieurs
- B- Une luxation congénitale de la hanche
- C- Une myopathie
- D- Une origine neurologique
- E- Une maladie Legg Perthes Calvés

45. Enfant de 5 ans se présente pour une boiterie aigue douloureuse avec un psoitis évoluant depuis 48 heures.

Quelles sont les signes cliniques et radiologiques en faveur d'une spondylodiscite aigue :

- A- Douleur à la palpation d'une épineuse dorsale localisée à la 6^{ème} vertèbre dorsale
- B- Perte des courbures physiologiques du dos
- C- Difficulté de s'asseoir
- D- Une difficulté de ramasser un objet par terre
- E- Une hypofixation disco-vertébrale sur une scintigraphie

46. Quels sont les signes cliniques à rechercher à l'inspection en faveur de la scoliose chez un enfant ?

- A- Une hanche plus saillante que l'autre
- B- Une tête mal centrée par rapport aux épaules
- C- Un coup de hache externe
- D- Des épines iliaques antérieur supérieur asymétrique
- E- Une gibbosité

47. À la radiographie standard, vous suspectez une tumeur osseuse maligne de l'extrémité inférieure du fémur chez un enfant de 10 ans. Quelle est l'étape suivante dans votre démarche diagnostic?

- A- Demander une TDM du fémur
- B- Demander une IRM du fémur
- C- Demander une scintigraphie osseuse
- D- Faire une biopsie de la masse
- E- Démarrer la chimiothérapie

48. M, garçon de 13 ans, victime d'un traumatisme de l'épaule droite, la radiographie de l'épaule face et profil a montré un décollement de l'épiphyse humérale supérieure avec un trait métaphyso-épiphysaire. Il s'agit

- A- D'un décollement épiphysaire type 1 de salter et harris
- B- D'un décollement épiphysaire type 2 de salter et harris
- C- D'un décollement épiphysaire type 3 de salter et harris
- D- D'un décollement épiphysaire type 4 de salter et harris
- E- D'un décollement épiphysaire type 4 de salter et harri

49. M, fille de 13 ans, victime d'un traumatisme violent de la hanche droite. La radiographie du bassin a objectivé une fracture basi-cervicale du col fémoral droit.

- A- Il s'agit d'une fracture type I selon la classification de Delbet
- B- Il s'agit d'une fracture type III selon la classification de Delbet
- C- Elle représente 50% des fractures du col fémoral de l'enfant
- D- Le risque de nécrose de la tête fémorale est inférieur à 10%
- E- L'épiphysiodèse du col fémoral est la complication la plus fréquente de ce type de fracture

50. Nouveau-né de 25 jours, hospitalisé pour ostéo-arthrite septique de la hanche droite avec sepsis sévère. Quel traitement antibiotique probabiliste vous démarrez en urgence ?

- A- Cefazoline: C1G (Kefzol) 150mg/kg/j + Gentamycine 5mg/kg/j
- B- Association amoxicilline-acide clavulanique 150mg/kg/j
- C- Association amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/j + Gentamycine 5mg/kg /j
- D- Association cefotaxime 40 mg/kg/j + vancomycine 30mg/kg/j
- E- Cefazoline (kefzol) 150 mg/kg/j + Vancomycine 60mg/kg/j + Gentamycine 5mg/kg/j

Code
candidat

Nom

Prénom

Remarques :

Université Cadi Ayyad

FMPM Marrakech

Année Universitaire 2025-2026

Session Janvier 2026

Maladies de L'enfant

4ème Année Médecine

CORRECTION

13/01/26
12:30

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☒	☒
Q2	☒	☒	☒	☐	☒
Q3	☐	☒	☒	☒	☐
Q4	☒	☒	☒	☒	☐
Q5	☐	☐	☒	☐	☐
Q6	☐	☐	☒	☐	☐
Q7	☒	☐	☐	☐	☐
Q8	☒	☒	☒	☐	☐
Q9	☐	☐	☒	☐	☐
Q10	☒	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☒	☐	☐
Q12	☐	☒	☐	☐	☐
Q13	☐	☒	☐	☐	☐
Q14	☐	☒	☐	☐	☐
Q15	☒	☐	☐	☐	☒
Q16	☐	☒	☐	☐	☐
Q17	☐	☒	☒	☐	☐
Q18	☒	☐	☒	☐	☒
Q19	☐	☒	☐	☐	☐
Q20	☒	☒	☒	☐	☐
Q21	☐	☒	☒	☐	☐
Q22	☐	☐	☒	☐	☐
Q23	☐	☒	☐	☒	☒
Q24	☒	☒	☒	☒	☐
Q25	☒	☐	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☒	☐	☒	☒
Q27	☐	☐	☒	☐	☒
Q28	☐	☒	☒	☒	☐
Q29	☐	☒	☐	☒	☐
Q30	☒	☒	☒	☒	☒
Q31	☐	☐	☐	☒	☐
Q32	☐	☐	☒	☐	☐
Q33	☐	☒	☒	☒	☐
Q34	☒	☐	☒	☒	☐
Q35	☐	☒	☒	☒	☒
Q36	☒	☒	☒	☒	☒
Q37	☐	☒	☐	☐	☐
Q38	☐	☒	☒	☒	☐
Q39	☐	☒	☐	☒	☐
Q40	☐	☐	☐	☒	☐
Q41	☐	☒	☐	☐	☐
Q42	☐	☒	☐	☐	☐
Q43	☐	☐	☐	☒	☐
Q44	☒	☒	☐	☐	☐
Q45	☐	☒	☒	☒	☐
Q46	☒	☒	☒	☐	☒
Q47	☐	☐	☒	☐	☐
Q48	☐	☐	☐	☒	☒
Q49	☐	☒	☐	☐	☐
Q50	☐	☐	☐	☐	☒